

児童・思春期精神医療入院診療計画書

患 者 氏 名	(男・女)	生年月日	年 月 日生 (歳)
診断名 (状態像名)	ICD-10(コード番号) :		

I. 発育・社会的環境

発達・生育歴 □特記事項なし □あり	家族構成 : (同居家族を含む)	社会的環境 :	c. 職歴
		a. 就学状況 b. 教育歴 (最終学歴 :)	d. 交友関係など

II. 入院時の状況

入院年月日	年 月 日 (曜日)	入 院 形 態	□任意入院 □医療保護入院 □措置入院 □その他
主 訴	患者 :		
	家族 (父・母・その他) :		
特別な栄養管理の必要性 : 有 ・ 無			
症状 および 問題行動 :			
A. 行 動 : a. 動 き : □多動 □寡動 □常同症 □拒絶症 □奇妙な動作 () b. 表 情 : □不安・恐怖・心配 □憂うつ □怒り・敵意 □無表情 c. 話 し 方 : □緘黙 □不明瞭 □吃音 □反響言語 d. そ の 他 : □睡眠障害 □食行動異常 □排泄障害 □習癖異常			
B. 情 緒 : □不安定 □無感情 □怒り・敵意 □不安・恐怖・心配 □高揚 □抑うつ気分 □感情の不調和			
C. 対 人 関 係 : □ひきこもり □自己中心的 □他罰的 □共感性欠如			
D. 知的機能 : □注意散漫 □興味限局 □記憶障害 □知的障害 □学習 (能力) 障害			
E. 意 識 : □見当識障害 □意識障害			
F. 意 欲 : □消極性 □意欲減退 □無為 □意欲亢進			
G. 行 為 : □自傷 □他害・暴行 □盗み □器物破損			
H. 知 覚 : □錯覚 □幻覚			
I. 思 考 : □心気症 □強迫観念・行為 □恐怖症 □自殺念慮・自殺企図 □離人体験 □病的な空想 □作為体験 □罪業妄想 □被害・関係妄想 □その他の妄想 () □連合障害			
J. そ の 他 : □病識欠如 □不登校 □計画的な行動がとれない □衝動コントロールの欠如 □主体性の未確立			
具体的な事柄 :			

(※) 担当者名

主治医	看護師	精神保健福祉士	公認心理師	その他

Ⅲ. 治療計画

(患者氏名)

予定治療期間 (週間/月) 本人の希望 : 家族の希望 : 目標の設定 : 同意事項 : ☐ 検査 ☐ 診断の確定 ☐ 薬物療法の調整 ☐ 精神症状の改善 ☐ 問題行動の改善 ☐ 生活リズムの改善 ☐ 家族関係の調整 ☐ 主体性の確立 ☐ 社会復帰 ☐ その他 ()	基本方針 : 	
	治療と検査 : A. 治療 : 精神療法 : ☐ 個人精神療法 : 回/週 ☐ 集団精神療法 : 回/週 ☐ 認知行動療法 : 回/週 ☐ 生活療法 : 回/週 薬物療法 : ☐ 抗精神病薬 ☐ 抗うつ薬 ☐ 抗躁薬 ☐ 抗不安薬 ☐ 抗てんかん薬 ☐ 睡眠導入剤 ☐ その他 () B. 検査 : 理化学検査 : ☐ 血液検査 ☐ 心電図 ☐ 脳波 ☐ X 線 ☐ CT (MRI) 検査 ☐ その他 () 心理検査 : ☐ 知能検査 () ☐ 性格検査 ()	
行動制限 : ☐ なし ☐ あり (電話、面会、外出、外泊、その他) 隔離室・個室使用 : ☐ なし ☐ あり		
退院後の目標 : ☐ 家庭内適応 ☐ 復学 ☐ 就労 ☐ デイケア ☐ 地域作業所 ☐ 施設入所 ☐ その他 ()		

Ⅳ. 家族へのアプローチ

面接 : ☐ 家族面接 : 回/週・月 (☐ 父親 ☐ 母親 ☐ その他 ()) ☐ 本人との同席面接 : 回/週・月 その他 : ☐ 家族療法 : 回/週・月 ☐ その他 : 回/週・月	具体的アプローチ

Ⅴ. 学校・教育へのアプローチ

入院中の教育的配慮 : ☐ 院内学級・院内分校への通級 (学) ☐ 地元 (原籍) 校への通学 ☐ 訪問学級 ☐ 通信教育 ☐ その他 ()	学校への具体的アプローチ : ☐ 本人の同意 ☐ 保護者の同意 ☐ 担任 ☐ 養護教諭 ☐ 生徒指導担当 ☐ その他 () ☐ 現状での問題点 () ☐ 今後の方向性 ()
---	--

説明日 年 月 日

(注) 内容は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わり得るものである。
(児童・思春期精神医療入院診療計画書記載上の注意)

1. 入院の早い時期に、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などの関係者が協力し、治療計画を決めること。
2. すみやかに、患者、保護者へ説明を行うとともに交付すること。(病状によっては、別紙2のみの交付でも可)